

Thomas Deniffel (* 06.04.1994 / # 8237)

Dr. med. Irmgard Kamilli
Fachärztin für Innere Medizin – Rheumatologie
Physikalische Therapie und Naturheilverfahren
Osteologe (DVO)

81547 München
Grünwalderstr. 72
Tel.: 0 89/62 11-20 51
Fax. 0 89/6211-20 52

Dr. med. Irmgard Kamilli – Grünwalderstr. 72 – 81547 München

Frau
Dr. med. Anke Röser
Ltd. Ärztin Zentrum Fußorthopädie
Im Hause

München, 22.03.2021/svl

n/ Patient

Betreff: Deniffel, Thomas, *06.04.1994

Sehr geehrte Frau Dr. Röser,

besten Dank für die Vorstellung des o.g. Patienten, der sich erstmals am 02.03.2021 in meiner Rheumasprechstunde vorstellte.

Diagnose:

1. HLA-B27 positive Oligoarthritis, DD beginnende Psoriasis-Arthropathie
2. Osteopenie
3. Vitamin D Mangel

Anamnese:

Der Patient berichtet, dass er seit 03/2020 Arthralgien am Zeh D2 links, zunehmend habe mit Schwellung Zehengrundgelenk und Zehenmittelfgelenk. Leichte Besserung nach Steroidinjektion. Er trug einen Entlastungsschuh bis 10/2020. Es erfolgte eine Operation am 16.02.2021 mit der Diagnose Ruptur Platte MTP 2 mit sekundären Knochenödem zweites Grundglied links, rezidivierende Synovitis MTP 2 links.

Knochendichte mittels DXA Halogic-Divcovery:

T-score Sch -0,9; LWS T -1,1.

Laborwerte:

Unauffällige internistische Werte, bis auf ein positives HLA-B27. Campylobacter negativ. ANA, ENA, ds-DNS unauffällig. Die weiteren Laborwerte waren unauffällig, insbesondere CRP mit 0,1 mg/dl.
Pathologisch war ein erniedrigtes Vitamin D mit 25,8 ng/ml.

Beurteilung und Verlauf:

Aufgrund der Anamnese des Patienten handelt es sich um eine rezidivierende Entzündung des zweiten Zehengrundgelenk, Erguss, Ödem und Ruptur der Plantarplatte, die am 16.02.2021 operiert wurde. Die durchgeführte Histologie ergab eine local synovialitis, würde zu einer

Psoriasis-Arthropathie passen. Im MRT vom 13.01.2021 wurde ebenfalls der Verdacht auf ein Psoriasis-Arthritis geäußert.

Im immunologischen Labor fiel ein positives HLA-B27 auf. Das weiteren immunologische Labor war unauffällig. Der Patient trägt nun ein Entlastungsschuh, so dass aktuell die Klinik nicht beurteilbar war.

Im Zusammenschau der Befunde könnte es sich um eine beginnende Oligoarthritis HBA-B27 positiv an MT2 handeln mit Ruptur der plantaren Platte. Da bei dem Patienten erstmals und einmalig nur der zweite Zeh betroffen ist und keine weiteren klinischen Symptome aufgetreten sind, wurde mit ihm besprochen, erstmals nur naturheilkundlich mit Basica und Teufelskralle zu arbeiten

Zusätzlich bei Vitamin D-Mangel Einnahme von Dekristol 20.000 IE/Woche.

Wie vereinbart wird sich der Patient im Juni 2021 erneut bei Ihnen vorstellen, im Anschluss auch in meiner rheumatologischen Sprechstunde. Mit dem Patienten wurde besprochen, falls weitere Arthritiden auftreten sollten, könnte jederzeit eine Basistherapie, z.B. MTX oder auch kurzfristig Prednisolon, begonnen werden.

Nachtrag vom 20.3.21 Patient berichtet über schuppige bläschenartige Veränderung an den Fingerkuppen, wäre vereinbar mit Psoriasis Pustulosa.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. med. Irmgard Kamilli
Fachärztin für Innere Medizin
Rheumatologie
Osteologie (DVO)



Thomas Deniffel (* 06.04.1994 / # 8237)



Schön Klinik München Harlaching · Harlacher Str. 51 · 81547 München

Herrn
Thomas Deniffel
Ellenberg 116
87499 Wildpoldsried

PRIVATKLINIK

Schön Klinik
München Harlaching
Grünwalder Straße 72
81547 München
Tel 089 6211-3420
Fax 089 6211-3422
PrivatklinikMuenchenHarlaching@
schoen-klinik.de
www.schoen-klinik.de

Zentrum für Fuß- und
Sprunggelenkchirurgie
Chefarzt:
Prof. Dr. med. Markus Walther
Telefon: +49 89 6211-2041
Telefax: +49 89 6211-2042
FUSSinfoMuenchen@
schoen-kliniken.de
Termin: +49 89 6211 2244

Herr Thomas DENIFFEL, geb. 06.04.1994

München,

Ellenberg 116, 87499 Wildpoldsried

Vorläufiger Entlassungsbericht

18. Februar 2021

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,

wir berichten über oben genannten Patienten, der vom 16.02.2021 bis zum 18.02.2021 im Zentrum für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie stationär behandelt wurde.

Diagnosen:

Ruptur plantare Platte MTP 2 mit sekundärem Knochenödem zweites Grundglied links
rezidivierende Synovitis MTP 2 links

Nebendiagnose:

keine bekannt

Allergien: ☒ keine bekannt

Wir weisen darauf hin, dass dieser Entlassungsbericht nur der Information des weiterbehandelnden Arztes dient und damit die Notwendigkeit der Krankenhausbehandlung sowie die sachgerechte Abrechnung danach nicht ausreichend beurteilt werden kann.

Therapie:

Operation am 16.2.2021:

totale Synovektomie und PE Entnahme MTP II links; Verkürzungs-OT MT II; Naht plantare Platte von plantar MTP II links

Anamnese:

Es erfolgt die geplante stationäre Aufnahme zur oben genannten operativen Therapie. Der Patient hatte sich zuvor in unserer Sprechstunde vorgestellt. Herr Deniffel berichtet seit April 2020 ohne erinnertes Trauma oder Überlastung über belastungsabhängige Schmerzen, welche mit einer Schwellung im Bereich des 2. Grundgelenkes sowie der 2. Zehe insbesondere in Höhe der Grundphalanx sowie des PIP Gelenkes links einhergehen. Eine Einlagenversorgung sowie zweimalige Injektion erbrachte keine Beschwerdelinderung.

SEITE 01/04

Schön Klinik München Harlaching
SE & Co KG
Sitz 83209 Prien am Chiemsee
Reg.-Gericht Traunstein
HRA-Nr. 6442
USt-ID-Nr. DE 185469297
Pers. haft. Gesellschafter
Schön Klinik Geschäftsführungs SE
Sitz 83209 Prien am Chiemsee
Reg.-Gericht Traunstein
HRB-Nr. 24937

Geschäftsführende Direktor
Dr. Mate Ivancic
Bankverbindung
Deutsche Bank
IBAN DE85 7007 0010 0834 8799 01
BIC DEUTDE33XXX

Lehrkrankenhaus der Paracelsus
Medizinische Privatuniversität Salzburg
Focus Klinikliste Top Nationales
Krankenhaus
Orthopädie
FIFA Medical Centre of Excellence
Medizinisches Zentrum des
Olympiastützpunktes Bayern

Thomas Deniffel (* 06.04.1994 / # 8237)

Klinischer Befund bei Aufnahme:

Keine signifikante Vor- und Rückfußfehlstellung, deutliche Weichteilschwellung Grundglied D2 links sowie im Bereich des zweiten Grundgelenkes mit auslösbaren Druckschmerz, keine Fehlstellung im PIP-Gelenk, klinisch kein massiver Hinweis für eine Instabilität im 2. Grundgelenk. Intakte Sehnenfunktion.

Bildgebende Diagnostik:

Röntgen linker Fuß unter Belastung vom 13.01.21:

Diskrete Überlänge des 2. Mittelfußknochens. Am 2. Strahl kein Hinweis für Osteolysen.

MRT linker Vorfuß vom 13.01.21:

Im Vergleich zum Vorbefund vom September komplette Ruptur der plantaren Platte am zweiten Grundglied, deutlicher Erguss im 2. Grundgelenk, rückläufiges Knochenödem in der End- und Mittelphalanx, noch deutliches Knochenödem im Metatarsale 2 Kopf sowie im Grundglied II. MR-tomografisch keine sicheren Zeichen für eine Kristallarthropathie. Anhand des klinischen Befundes ist differenzialdiagnostisch eine Psoriasisarthritis möglich

Röntgen Vorfuß links in 2 Ebenen postoperativ 17.02.2021:

Z.n. Weil Osteotomie Metatarsale 2 mit regelrechter Lage des Osteosynthesematerials.

Labor

Bezeichnung	Ref.-Bereich	Einheit	13.1.21 16:48	13.2.21 10:55
Ergebnis engl. nCoV-RNA (Wuhan)				* nicht nachgewie sen
CRP	bis 0.5	mg/dl	0.1	
Natrium	136-145	mmol/l	138	
Kalium	3.7 - 5.5	mmol/l	4.4	
Harnstoff	16.6-48.5	mg/dl	17	
Kreatinin	0.67-1.17	mg/dl	1.04	
GPT	bis 41	U/l	60↑	
glomeruläre Filtrationsrate	80-140	ml/min/1,7	* 86.3↓	
Leukozyten	4.0-10.0	x 10 ³	8.8	
Erythrozyten	4.5-5.9	x 10 ⁶ /µl	5.2	
Hämoglobin	14.0-17.5	g/dl	16.5	
Hämatokrit	40.0-52.0	%	46.0	
MCV	80.0-96.0	fl	88.3	
MCH	28.0-33.0	pg	31.7	
MCHC	33.0-36.0	g/dl	35.9	
Thrombozyten	139-335	10 ³ /µl	294	
Quick	71-118	%	100	
INR			* 1.01	
PTT	22,7-32,5	sec	* 26.0	

Material

Abstrich

Klinischer Verlauf:

Nach Besprechung der verschiedenen Behandlungsoptionen, sowie der Vor- und Nachteile eines konservativen vs. eines operativen Vorgehens wurde die Indikation zur Operation gestellt. Der Eingriff sowie der postoperative Verlauf gestalteten sich komplikationslos. Wir begannen eine Mobilisation des Patienten am ersten

SEITE 02/04

Schön Klinik München Harlaching

Deniffel, Thomas * 06.04.1994, M
FallNr.: 80244045 P

Thomas Deniffel (* 06.04.1994 / # 8237)

postoperativen Tag im Verbandschuh mit schmerzadaptierter Belastung der operierten Extremität. Es erfolgte eine Anleitung des Patienten zur eigenständigen Durchführung einer mobilisierenden Krankengymnastik des oberen Sprunggelenkes in Dorsalextension und Plantarflexion.

Am 18.02.2021 konnten wir Thomas Deniffel in Ihre weitere fachärztliche Behandlung entlassen. Zum Entlassungszeitpunkt sahen wir reizlose Wundverhältnisse.

Klinischer Befund bei Entlassung:

Der Allgemeinzustand ist gut. Es bestehen reizlose Wundverhältnisse. Die Sensomotorik ist intakt. Die Beschwerdesymptomatik ist unter Analgesie gut kompensiert.

Procedere:

Wundversorgung

Kramer Verband 2 Wochen.

Wundkontrolle und Verbandswechsel: 1-2 x/ Woche.

Fadenzug: 2 Wochen postoperativ.

Hochlagerung: 2 Wochen, danach bei vermehrter Schwellung.

Der redressierende Vorfußverband (Kramer-Verband) schützt die Weichteile und hat eine große Bedeutung für den Therapieerfolg. Bei verrutschtem oder fehlerhaft angelegtem Verband besteht das Risiko erneuter Fehlstellungen und eines schlechten Operationsergebnisses. Die Großzehe sollte gerade stehen. Eine „Überkorrektur“ ist dabei ebenso zu vermeiden. Eine Videoanleitung zur Anlage eines Vorfußverbandes findet sich unter www.kramerverband.my-medibook.de

Medikamente

Nach individueller Risikoabschätzung kann bei fehlender Ruhigstellung des Sprunggelenks und Vollbelastung des Beins auf eine medikamentösen Thromboseprophylaxe verzichtet werden.

Analgetische Therapie: Nur nach Bedarf; bei NSAR wie Voltaren oder Ibuprofen mit Kontrolle der Nierenwerte im Verlauf.

Zur Unterstützung des Kollagenstoffwechsels ist die Einnahme von Vitamin C 500 mg p.o. 1-0-1 für 3 Monate möglich.

Zur Unterstützung des Knochenstoffwechsels empfehlen wir die Einnahme von Vitamin D3 p.o. 1000 IE 1-0-1 für 3 Monate.

Hilfsmittel

Verbandschuh für 6 Wochen.

Unterarmgehstützen nur bei Bedarf unterstützend in den ersten Tagen postoperativ.

plantarisierender Tapeverband MTP II 6 Wochen

starre Einlage bis Ende 3. postop. Monat

Belastung

Vollbelastung im Verbandschuh.

Physiotherapie und Rehabilitation

Lymphdrainage: Fortführung bei Schwellung.

selbständig voller Bewegungsumfang im oberen Sprunggelenk, selbständig Fortführung KG Zehengrundgelenk I, II, III, IV, V in Dorsalext./Plantarflex.,

keine KG MTP II für 6 Wochen

nach 6 Wochen Gangschulung im Konfektionsschuh mit starrer Einlage, Rigidusfeder

4 Monate postop. kein Zehenspitzenstand

Wiedervorstellung

Ambulante Wiedervorstellung 6 Wochen postoperativ zur klinischen und radiologischen Kontrolle (Röntgen Fuß 3 Ebenen unter Belastung), alternativ weitere Betreuung beim niedergelassenen Kollegen.

Im Falle einer vermehrten Sekretion der Wunde, zunehmender Rötung oder unklarer Schmerzzunahme

SEITE 03/04

Schön Klinik München Harlaching

Deniffel, Thomas * 06.04.1994, M
FallNr.: 80244045 P

Thomas Deniffel (* 06.04.1994 / # 8237)

empfehlen wir eine kurzfristige ärztliche Kontrolle.

Wir bitten um zeitnahe Terminvereinbarung unter Tel.: 089 / 6211 - 2244 oder Email: MHA-Sprechstunden-Termine@schoen-kliniken.de
Onlineterminvereinbarung unter: <https://www.doctolib.de/institut/muenchen/schoen-klinik-muenchen-harlaching-fusschirurgie-sprungelenkchirurgie>

Medikation

Aufnahme

Entlassung

Wirkstoffbezeichnung und -stärke	Darr.-form	Gabeschema (Dosierung)
Pantoprazol 40mg	p.o.	1-0-0-0 (Stück)

Bem: solange NSAR-Gabe

Ibuprofen 400mg	p.o.	1-1-1-1 (Stück)
-----------------	------	-----------------

Bem: im Verlauf reduzieren, beenden

Paracetamol 500mg	p.o.	1-1-1-1 (Stück)
-------------------	------	-----------------

Bem: im Verlauf reduzieren, beenden

Vitamin C (Ascorbinsäure) 500mg	p.o.	1-1-1-1 (Stück)
---------------------------------	------	-----------------

Bem: für den Monat

Enoxaparin 40mg	s.c.	0-0-0-1 (Stück)
-----------------	------	-----------------

Bem: nur wenn eine Vollbelastung nicht umgesetzt werden kann

Verordnungen

ausgestellt am	Formular	Inhalt
16.02.2021	Arbeitsunfähigkeit EMGMT	Erstbescheinigung, voraussichtlich arbeitsunfähig bis einschließlich 25.02.2021

16.02.2021	Rezept-Muster 16	Pantoprazol 40mg Tbl N4 1-0-0-0
	Entlassmanagement	Enoxaparin 40mg s.c. 0-0-0-1

Nachfolgende Versorgungseinrichtung

Mitgegebene Befunde

Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit und verbleiben
mit freundlichen kollegialen Grüßen



Prof. Dr. Markus Walther
Ärztlicher Direktor

Dr. med. Anke Röser
Leitende Ärztin

Dr. med. Quirin Hartmann
Assistenzarzt

SEITE 04/04

Schön Klinik München Harlaching

Deniffel, Thomas, * 06.04.1994, M
FallNr.: 80244045 P

Thomas Deniffel (* 06.04.1994 / # 8237)

Schön Klinik München Harlaching

Pat.: Deniffel, Thomas

Geb.Dat.: 06.04.1994, M

Kumulativbefund

Auftragsnummer	Referenzbereich	Einheit	21500684	05702319
Probenentnahmedat.			13.01.2021	13.02.2021
Probenentnahmezeit			16:48	10:55
Befundersteller			Hauslabor	MEDAT- MIBI-KC

Coronadiagnostik

Ergebnis engl.				*					
nCoV-RNA (Wuhan)				nicht nachgewiesen					

Klinische Chemie

CRP	bis 0,5	mg/dl	0,1						
Natrium	136-145	mmol/l	138						
Kalium	3,7 - 5,5	mmol/l	4,4						
Harnstoff	16,6-48,5	mg/dl	17						
Kreatinin	0,67-1,17	mg/dl	1,04						
GPT	bis 41	U/l	60↑						
glomeruläre Filtrationsrate	80-140	ml/min/1,73m²	* 86,3↓						

Kleines Blutbild

Leukozyten	4,0-10,0	x 10³	8,8						
Erythrozyten	4,5-5,9	x 10⁶/µl	5,2						
Hämoglobin	14,0-17,5	g/dl	16,5						
Hämatokrit	40,0-52,0	%	46,0						
MCV	80,0-96,0	fL	88,3						
MCH	28,0-33,0	pg	31,7						
MCHC	33,0-36,0	g/dl	35,9						
Thrombozyten	139-335	10³/µl	294						

Gerinnung

Quick	71-118	%	100						
INR			* 1,01						
PTT	22,7-32,5	sec	* 26,0						

Labor Becker und Kollegen

Material				Abstrich					
----------	--	--	--	----------	--	--	--	--	--

Bemerkungen

05702319 Ergebnis engl. 13.02.2021, 10:55

SARS-CoV-2 RNA (Coronavirus) was not detected.

21500684 glomeruläre Filtrationsrate 13.01.2021, 16:48

Die Berechnung der GFR mit der MDRD-Formel bezieht sich auf eine Körperoberfläche von 1,73 m² und ist vorgesehen für Personen im Alter zwischen 18 und 70 Jahren.

21500684 INR 13.01.2021, 16:48

Interpretation der INR Werte:

INR Wert ist ein Vergleichswert unter Antikoagulationstherapie

Thomas Deniffel (* 06.04.1994 / # 8237)

Thomas Deniffel
80244045

Bemerkungen

INR 1,0 Normalbereich
INR 2,0-3,0 niedrig dosierte Antikoagulation
INR 3,0-4,5 hoch dosierte Antikoagulation

ohne Gabe von Antikoagulationstherapie liegt die Aussagekraft beim Quick

21500684

PTT

13.01.2021, 16:48

Eine verlängerte PTT kann auch durch das Vorliegen von Lupus Antikoagulation
(z.B. Autoimmunerkrankungen) bedingt sein.

Sollten keine anderen Ursachen (Faktorenmangel, Heparintherapie) für die verlängerte PTT bekannt
sein, empfiehlt sich der Nachweis des Lupusantikoagulation.

Thomas Deniffel (* 06.04.1994 / # 8237)



SCHÖN
KLINIK
München Harlaching
Privatlinik

Schön Klinik München Harlaching · Harlacher Str. 51 · 81547 München

Herrn
Thomas Deniffel
Ellenberg 116
87499 Wildpoldsried

PRIVATKLINIK

Schön Klinik
München Harlaching
Grünwalder Straße 72
81547 München
Tel 089 6211-3420
Fax 089 6211-3422
PrivatklinikMuenchenHarlaching@
schoen-klinik.de
www.schoen-klinik.de

Zentrum für Fuß- und
Sprunggelenkchirurgie
Chefarzt:
Prof. Dr. med. Markus Walther
Telefon: +49 89 6211-2041
Telefax: +49 89 6211-2042
FUSSinfromuenchen@
schoen-kliniken.de
Termin: +49 89 6211 2244

BESCHEINIGUNG

18.02.2021

Wir bescheinigen Herrn Thomas Deniffel, geb. 06.04.1994, dass sich dieser seit dem 16. - 18.02.2021 bei uns in
stat. Behandlung befand.

Prof. Dr. Markus Walther
Ärztlicher Direktor

Schön Klinik München Harlaching
Taina Ransmayr
Station 42
Krankenstation Harlacher Str. 51
81547 München
Tel. +49 89 6211-3420
Fax +49 89 6211-3422

Schön Klinik München Harlaching
SE & Co KG
Sitz 83209 Prien am Chiemsee
Reg.-Gericht Traunstein
HRA-Nr. 6442
USt-ID-Nr. DE 185469297
Pers. haft. Gesellschafter
Schön Klinik Geschäftsführungs SE
Sitz 83209 Prien am Chiemsee
Reg.-Gericht Traunstein
HRB-Nr. 24937

Geschäftsführende Direktor
Dr. Mate Ivancic
Bankverbindung
Deutsche Bank
IBAN DE85 7007 0010 0834 8799 01
BIC DEUTDE33XXX

Lehrkrankenhaus der Paracelsus
Medizinische Privatuniversität Salzburg
Focus Klinikliste Top Nationales
Krankenhaus
Orthopädie
FIFA Medical Centre of Excellence
Medizinisches Zentrum des
Olympiastützpunktes Bayern

Thomas Deniffel (* 06.04.1994 / # 8237)



Schön Klinik München Harlaching · Harlacher Str. 51 · 81547 München

Herrn
Dr. med. Paulus Eberle
Allgemeinmedizin
An der Wilhelmshöhe 28
87463 Probstried-Dietmannsried

Schön Klinik
München Harlaching
Harlacher Straße 51
81547 München
Tel 089 6211-0
Fax 089 6211-1111
KlinikMuenchenHarlaching@
schoen-klinik.de
www.schoen-klinik.de
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Zentrum für Fuß- und
Sprunggelenkchirurgie
Chefarzt:
Prof. Dr. med. Markus Walther
Telefon: +49 89 6211-2041
Telefax: +49 89 6211-2042
FUSSinfo@muenchen@
schoen-kliniken.de
Termin: +49 89 6211 2244

Herr Thomas DENIFFEL, geb. 06.04.1994

Ellenberg 116, 87499 Wildpoldsried
Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Eberle,

München,
17.01.2021

wir berichten über oben genannten Patienten, der sich am **13.01.2021** in unserer Sprechstunde für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie vorstellte.

Diagnosen:

Ruptur plantare Platte MTP 2 mit sekundärem Knochenödem zweites Grundglied links
rezidivierende Synovitis MTP 2 links

Therapieempfehlung:

Es erfolgte eine ausführliche Befunderläuterung. Zur Vermeidung einer sekundären Fehlstellung der Kleinzehe sowie sekundären Arthrose im 2. Grundgelenk besteht die Indikation zur operativen Rekonstruktion der plantaren Platte. Zusätzlich sollte eine PE-Entnahme der Synovia aus dem 2. Grundgelenk erfolgen um eine chronische entzündliche Grunderkrankung abschließend auszuschließen (bei klinisch möglichen Aspekt einer Psoriasisarthritis). Ich habe den Patienten ausführlich über die Erfolgschancen und Risiken sowie über Therapiealternativen informiert. Einleitung der OP Vorbereitung für den 16. Februar 2021.

Anamnese:

Erstvorstellung. Der Patient berichtet seit April 2020 ohne Trauma und ohne Überlastung über belastungsabhängige Schmerzen welche mit einer Schwellung einhergehen im Bereich des 2. Grundgelenkes sowie der 2. Zehe insbesondere in Höhe der Grundphalanx sowie des PIP Gelenkes links. Eine Einlagenversorgung erbringt keine Beschwerdelinderung. Eine 2-malige Injektion zeigte ebenfalls keine langfristige Wirkung. Unter und nach Belastung kommt es zu einer deutlichen Anschwellung mit deutlichen Schmerzen im 2. Strahl welche mit Ibuprofen gut zu reduzieren sind.

Klinischer Befund:

Keine signifikante Vor- und Rückfußfehlstellung, deutliche Weichteilschwellung Grundglied D2 links sowie im Bereich des zweiten Grundgelenkes mit auslösbaren Druckschmerz, keine Fehlstellung im PIP-Gelenk, klinisch kein massiver Hinweis für eine Instabilität im 2. Grundgelenk. Intakte Sehnenfunktion.

Bildgebende Diagnostik:

Röntgen linker Fuß unter Belastung vom 13.01.21:

Diskrete Überlänge des 2. Mittelfußknochens. Am 2. Strahl kein Hinweis für Osteolysen.

SEITE 01/02

Schön Klinik München Harlaching
SE & Co KG
Sitz 83209 Prien am Chiemsee
Reg.-Gericht Traunstein
HRA-Nr. 6442
USt-ID-Nr. DE 185469297
Pers. haft. Gesellschafter
Schön Klinik Geschäftsführungs SE
Sitz 83209 Prien am Chiemsee
Reg.-Gericht Traunstein
HRB-Nr. 24937

Geschäftsführende Direktor
Dr. Mate Ivancic
Bankverbindung
Deutsche Bank
IBAN DE15 7007 0010 0834 8799 00
BIC DEUTDE33XXX

Lehrkrankenhaus der Paracelsus
Medizinische Privatuniversität Salzburg
Focus Klinikliste Top Nationales
Krankenhaus
Orthopädie
FIFA Medical Centre of Excellence
Medizinisches Zentrum des
Olympiastützpunktes Bayern

Thomas Deniffel (* 06.04.1994 / # 8237)

MRT linker Vorfuß vom 13.01.21:

Im Vergleich zum Vorbefund vom September komplette Ruptur der plantaren Platte am zweiten Grundglied, deutlicher Erguss im 2. Grundgelenk, rückläufiges Knochenödem in der End- und Mittelfalanx, noch deutliches Knochenödem im Metatarsale 2 Kopf sowie im Grundglied II. MR-tomografisch keine sicheren Zeichen für eine Kristallarthropathie. Anhand des klinischen Befundes ist differenzialdiagnostisch eine Psoriasisarthritis möglich

Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit und verbleiben
mit freundlichen kollegialen Grüßen

Prof. Dr. Markus Walther
Ärztlicher Direktor

Dr. med. Anke Röser
Leitende Ärztin

Nachrichtlich an:

Thomas Deniffel, Ellenberg 116, 87499 Wildpoldsried

Thomas Deniffel (* 06.04.1994 / # 8237)



Schön Klinik München Harlaching · Harlacher Str. 51 · 81547 München

Herrn
Dr. med. Paulus Eberle
Allgemeinmedizin
An der Wilhelmshöhe 28
87463 Probstried-Dietmannsried

Schön Klinik
München Harlaching
Harlacher Straße 51
81547 München
Tel 089 6211-0
Fax 089 6211-1111
KlinikMuenchenHarlaching@
schoen-klinik.de
www.schoen-klinik.de
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Zentrum für Fuß- und
Sprunggelenkchirurgie
Chefarzt:
Prof. Dr. med. Markus Walther
Telefon: +49 89 6211-2041
Telefax: +49 89 6211-2042
FUSSinfoMuenchen@
schoen-kliniken.de
Termin: +49 89 6211 2244

Herr Thomas DENIFFEL, geb. 06.04.1994

München,

Ellenberg 116, 87499 Wildpoldsried

17.01.2021

Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Eberle,

wir berichten über oben genannten Patienten, der sich am **13.01.2021** in unserer Sprechstunde für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie vorstellte.

Diagnosen:

Ruptur plantare Platte MTP 2 mit sekundärem Knochenödem zweites Grundglied links
rezidivierende Synovitis MTP 2 links

Therapieempfehlung:

Es erfolgte eine ausführliche Befunderläuterung. Zur Vermeidung einer sekundären Fehlstellung der Kleinzehe sowie sekundären Arthrose im 2. Grundgelenk besteht die Indikation zur operativen Rekonstruktion der plantaren Platte. Zusätzlich sollte eine PE-Entnahme der Synovia aus dem 2. Grundgelenk erfolgen um eine chronische entzündliche Grunderkrankung abschließend auszuschließen (bei klinisch möglichen Aspekt einer Psoriasisarthritis). Ich habe den Patienten ausführlich über die Erfolgschancen und Risiken sowie über Therapiealternativen informiert. Einleitung der OP Vorbereitung für den 16. Februar 2021.

Anamnese:

Erstvorstellung. Der Patient berichtet seit April 2020 ohne Trauma und ohne Überlastung über belastungsabhängige Schmerzen welche mit einer Schwellung einhergehen im Bereich des 2. Grundgelenkes sowie der 2. Zehe insbesondere in Höhe der Grundphalanx sowie des PIP Gelenkes links. Eine Einlagenversorgung erbringt keine Beschwerdelinderung. Eine 2-malige Injektion zeigte ebenfalls keine langfristige Wirkung. Unter und nach Belastung kommt es zu einer deutlichen Anschwellung mit deutlichen Schmerzen im 2. Strahl welche mit Ibuprofen gut zu reduzieren sind.

Klinischer Befund:

Keine signifikante Vor- und Rückfußfehlstellung, deutliche Weichteilschwellung Grundglied D2 links sowie im Bereich des zweiten Grundgelenkes mit auslösbaren Druckschmerz, keine Fehlstellung im PIP-Gelenk, klinisch kein massiver Hinweis für eine Instabilität im 2. Grundgelenk. Intakte Sehnenfunktion.

Bildgebende Diagnostik:

Röntgen linker Fuß unter Belastung vom 13.01.21:
Diskrete Überlänge des 2. Mittelfußknochens. Am 2. Strahl kein Hinweis für Osteolysen.

SEITE 01/02

Schön Klinik München Harlaching
SE & Co KG
Sitz 83209 Prien am Chiemsee
Reg.-Gericht Traunstein
HRA-Nr. 6442
USt-ID-Nr. DE 185469297
Pers. haft. Gesellschafter
Schön Klinik Geschäftsführungs SE
Sitz 83209 Prien am Chiemsee
Reg.-Gericht Traunstein
HRB-Nr. 24937

Geschäftsführende Direktor
Dr. Mate Ivancic
Bankverbindung
Deutsche Bank
IBAN DE15 7007 0010 0834 8799 00
BIC DEUTDE33XXX

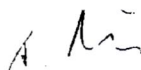
Lehrkrankenhaus der Paracelsus
Medizinische Privatuniversität Salzburg
Focus Klinikliste Top Nationales
Krankenhaus
Orthopädie
FIFA Medical Centre of Excellence
Medizinisches Zentrum des
Olympiastützpunktes Bayern

Thomas Deniffel (* 06.04.1994 / # 8237)

MRT linker Vorfuß vom 13.01.21:

Im Vergleich zum Vorbefund vom September komplette Ruptur der plantaren Platte am zweiten Grundglied, deutlicher Erguss im 2. Grundgelenk, rückläufiges Knochenödem in der End- und Mittelphalanx, noch deutliches Knochenödem im Metatarsale 2 Kopf sowie im Grundglied II. MR-tomografisch keine sicheren Zeichen für eine Kristallarthropathie. Anhand des klinischen Befundes ist differenzialdiagnostisch eine Psoriasisarthritis möglich

Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit und verbleiben
mit freundlichen kollegialen Grüßen



Prof.Dr. Markus Walther
Ärztlicher Direktor

Dr. med. Anke Röser
Leitende Ärztin

Nachrichtlich an:

Thomas Deniffel, Ellenberg 116, 87499 Wildpoldsried